

«Хронічний вірусний гепатит С»

1. Завдання, що виконуються здобувачем освіти на станції:

- продемонструвати комунікативні навички (*привітатися з пацієнтом; назвати себе; запитати, як звертатися до нього; запропонувати зручно сісти; забезпечити під час бесіди ізоляцію від впливу різних подразників (сторонні розмови, телефонні дзвінки, тощо); сісти поруч за стіл*).
- спитати скарги та деталізувати їх;
- вияснити анамнез захворювання (у т.ч. епідеміологічний та парентеральний) анамнез та анамнез життя;
- продемонструвати практичну навичку “Перкусія печінки за методом Курлова”;
- виділити провідний синдром;
- надати рекомендації щодо профілактики та пропаганди здорового способу життя;
- продемонструвати невербальні компоненти ведення бесіди (тактовність, ввічливий тон, вираження емпатії тощо).

2. Клінічні кейси (сценарії, задачі), які відпрацьовуються на станції з пакетами додаткових досліджень:

- Сценарій «Збір скарг та анамнезу, об’єктивне обстеження хворого з діагнозом «Хронічний вірусний гепатит С».

• Додаток 1. Об’єктивне обстеження пацієнта

Стан середньої тяжкості. Ріст 160 см, вага 55 кг. Температура тіла 36,8 °С. Периферичні лімфатичні вузли не збільшені. Шкіра та склери субіктеричні. У легенях – везикулярне дихання. Частота дихальних рухів 18 за хв. Тони серця приглушені ритмічні. ЧСС=Пульс=86 за хв., Артеріальний тиск 120/80 мм рт.ст. Живіт м’який безболісний. Селезінка виступає з під краю реберної дуги на 1 см. Випорожнення та сечовипускання без особливостей.

3. Інформація для студента – алгоритм роботи на станції:

Ви – лікар приймального відділення. До Вас звернулася жінка.

Алгоритм дій здобувача.

	<i>Дії здобувача освіти</i>	<i>Текст стандартизованого пацієнта</i>
1.ПРОДЕМОНСТРУВАТИ НАВИЧКИ КОМУНІКАЦІЙ.		
<i>Привітатися з пацієнтом</i>	Доброго дня.	Доброго дня.
<i>Представитися, позначити свою роль</i>	Я лікар-терапевт, Володимир Іванович.	Дуже приємно.
<i>Запитати пацієнтку, як до неї можна</i>	Як я можу до Вас звертатися?	Марина Олексіївна

<i>звертатися</i>		
<i>Уточнити вік пацієнтки</i>	Скільки Вам років?	48 років
<i>Уточнити заняттєву активність</i>	Ви працюєте?	Не працюю.
2.ІНШЕ (В Т.Ч. ЛЕГАЛЬНІ ТА ЕТИЧНІ АСПЕКТИ):		
<i>Отримати інформовану згоду на проведення обстеження</i>	Ви даєте свою згоду на проведення обстеження?	Так
Інформувати пацієнта про «лікарську таємницю»	Наша розмова конфіденційна, можете мені довіритися.	Добре.
3.ЗБІР СКАРГ ТА АНАМНЕЗУ		
<i>Запитати скарги пацієнтки</i>	Марино Олексіївно, що Вас турбує?	Я поживтіла, в мене постійна тривога і я не хочу їсти.
	Нудота, блювота, здуття живота, важкість в правому підребер'ї?	Блювоти не було, а нудота так. І важкість в правому підребер'ї буває часто.
	Температура тіла підвищувалась?	Ні
<i>Запитати анамнез захворювання пацієнтки</i>	Коли Ви замітили жовтяницю шкіри?	Тиждень тому.
	Розкажіть будь ласка з чого все почалося?	В мене десь рік турбує тривога, поганий сон. Потім я помітила, що я дуже схудла, у мене погіршився апетит, з'явилися нудота.
	Ви до лікаря звертались за допомогою?	Ні. Думала все через тривогу.
	Що зараз Вас змусило звернутися до лікаря?	Тиждень тому помітила жовтяницю шкіри і вирішила прийти на прийом.
<i>Запитати епідеміологічний анамнез:</i>	Марино Олексіївно, чи були випадки подібних захворювань серед близьких та знайомих?	Ні, не пам'ятаю .
<i>Запитати парентеральний анамнез:</i>	У Вас були протягом 6 місяців такі маніпуляції як видалення зуба, внутрішньовенні ін'єкції,	Ні.

	тощо?	
<i>Запитати анамнез життя пацієнтки</i>	Чим хворіли протягом життя?	ГРВІ, пневмонія.
	Туберкульоз, вірусні гепатити, цукровий діабет ?	Ні
	Операції, травми протягом життя?	Ні
	Алергійні реакції? Непереносимість ліків?	Ні
	Шкідливі звички? Вживання ін'єкцій нонаркотичних препаратів?	Так, але це було раніше, я зав'язала.
ПРОДЕМОНСТРУВАТИ КОМУНІКАТИВНІ НАВИЧКИ:		
<i>Попросити пацієнта зняти одяг</i>	Маріно Олексіївно, зараз я Вам проведу перкусію печінки, будь ласка зніміть одяг.	Так, зараз.
ІНШЕ (В Т.Ч. ЛЕГАЛЬНІ ТА ЕТИЧНІ АСПЕКТИ)		
Обробити руки антисептиком на гігієнічному рівні.		
4. ОБ'ЄКТИВНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ПАЦІЄНТА Додаткова інформація об'єктивного обстеження пацієнта надається здобувачу у паперовому вигляді.		
<i>Провести перкусію печінки за методом Курлова</i>	Перший розмір. Верхня межа: коректна перкусія по правій середньо-ключичній лінії, визначити точки переходу ясного легеневого звуку в тупий печінковий	Сказати «Притуплення» , коли здобувач буде перкутувати в 6 м/р
	Нижня межа: коректна перкусія по правій серединно-ключичній лінії від пупка вгору до визначення точки переходу тимпанічного звуку в тупий. Поєднавши дві точки, виміряти перший розмір печінки за методом Курлова.	Сказати «Притуплення» , коли здобувач буде перкутувати не доходячи до правого підребер'я 3 см
	Другий розмір. За верхню межу цього розміру умовно приймають точку, що лежить на	

	одному рівні з верхньою межею першого розміру печінкової тупості (через цю точку проводять горизонталь до перетину з серединною лінією)	
	Нижня межа: коректна перкусія по серединній лінії живота до появи печінкової тупості. З'єднавши ці точки, вимірюють другий розмір печінки за методом Курлова.	Сказати «Притуплення» , коли здобувач буде перкутувати по серединній лінії живота не доходячи до 3 точки 9 см
	Третій розмір. Верхня межа відповідає верхній точці другого розміру печінки.	
	Нижня межа: коректна перкусія поблизу лівої реберної дуги перпендикулярно до неї, починаючи перкусію приблизно з передньої пахвової лінії. З'єднавши ці точки, вимірюють третій розмір печінки за методом Курлова.	Сказати «Притуплення» , коли здобувач буде перкутувати поблизу лівої реберної дуги не доходячи до 3 точки 8 см
	Розміри печінки по Курлову	12х9х8 см
ПРОДЕМОНСТРУВАТИ КОМУНІКАТИВНІ НАВИЧКИ:		
<i>Уточнити самопочуття</i>	Як Ви себе почуваєте, все добре? Одягайтеся.	Так. Добре.
<i>Пояснити подальші дії</i>	Марино Олексіївно, враховуючи наявність збільшення печінки, жовтяниці, раджу Вам подальше дообстеження в стаціонарі для встановлення заключного діагнозу і призначення ліків.	Зрозуміла.
5. ВИДІЛИТИ ПРОВІДНИЙ СИНДРОМ		
	Провідний синдром – синдром гепатомегалії.	
6. ПРОФІЛАКТИКА ТА ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ		
	Збалансована дієта: зменшить споживання надмірно жирних та солодких продуктів. Якщо у	Дякую, лікарю.

	вас поганий апетит, намагайтеся їсти малими порціями, але частіше. Не вживайте алкоголь, не палить. Регулярні помірні фізичні вправи зменшують стрес або депресію, тонізують, допомагають зміцнити імунну систему.	
ПРОДЕМОНСТРУВАТИ КОМУНІКАТИВНІ НАВИЧКИ:		
	Марино Олексіївно, Вам все зрозуміло?	Все зрозуміла
	Можливо у Вас є запитання до мене?	Немає
	Якщо Вам все зрозуміло і немає до мене більше питань, я дякую Вам за спілкування. До зустрічі.	Вам дякую лікарю, до зустрічі.